

Métodos hormonales combinados y progestínicos

1. Introducción y relevancia clínica

La **anticoncepción hormonal** constituye uno de los pilares de la **salud sexual y reproductiva** en Chile y el mundo.

Permite a las mujeres **controlar la fertilidad, espaciar embarazos y reducir riesgos obstétricos**, siendo además útil en el tratamiento de patologías ginecológicas como **dismenorrea, síndrome premenstrual y endometriosis**.

Los **métodos hormonales combinados** (estrógeno + progestina) y los **métodos solo progestínicos** son ampliamente utilizados y forman parte del **arsenal garantizado por el programa nacional de planificación familiar del MINSAL**.

- En EUNACOM, es frecuente que pregunten:
 - El **mecanismo de acción principal** de los anticonceptivos hormonales.
 - Sus **contraindicaciones absolutas y relativas (criterios OMS)**.
 - Cuál es el método más adecuado según **edad, comorbilidad o lactancia**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Principio general

Los anticonceptivos hormonales actúan **inhibiendo la ovulación y modificando el endometrio y el moco cervical**, impidiendo la fecundación o la implantación.

b. Mecanismos de acción

Componente	Mecanismo principal	Efecto
Progestina	Inhibe el pico de LH → suprime la ovulación	Inhibe ovulación (principal mecanismo)

	Espesa el moco cervical	Dificulta paso de espermatozoides
	Atrofia endometrial	Impide implantación
Estrógeno (etinilestradiol o valerato de estradiol)	Inhibe FSH → suprime desarrollo folicular	Estabiliza endometrio y reduce sangrado intermenstrual

El **efecto anticonceptivo más importante** es la **inhibición de la ovulación** mediada por la progestina.

c. Tipos de progestinas más utilizadas

Generación	Ejemplo	Características
1. ^a	Noretindrona	Androgénica leve
2. ^a	Levonorgestrel	Alta potencia, más efectos androgénicos
3. ^a	Desogestrel, gestodeno	Menos androgénicos
4. ^a	Drospirenona	Propiedades antiandrogénicas y antimineralocorticoides

3. Clasificación de los métodos hormonales

a.

Métodos combinados (estrógeno + progestina)

1. Anticonceptivos orales combinados (AOC):

- Etinilestradiol + levonorgestrel, desogestrel, drospirenona, etc.
- Presentaciones de 21/7, 24/4 o uso continuo.

2. Parche transdérmico (Evra®):

- Estradiol + norelgestromina, reemplazo semanal.

3. Anillo vaginal (Nuvaring®):

- Etinilestradiol + etonogestrel, uso de 3 semanas con 1 de descanso.

b.

Métodos solo progestínicos

1. Píldora diaria de progestina (minipíldora):

- Desogestrel o levonorgestrel.
- Se usa sin intervalos.

2. Inyectables:

- Acetato de medroxiprogesterona 150 mg IM cada 3 meses (Depo-Provera®).

3. Implante subdérmico:

- Etonogestrel (Implanon®), duración 3 años.

4. DIU liberador de levonorgestrel:

- Mirena® (5 años), Jaydess® (3 años).

☐ En lactancia, obesidad o contraindicaciones a estrógenos → **usar métodos solo progestínicos.**

4. Indicaciones clínicas

a.

Anticoncepción

- Prevención eficaz del embarazo (>99% eficacia teórica).
- Elección personalizada según edad, comorbilidad, hábitos y preferencia.

b.

Indicaciones no anticonceptivas

- Dismenorrea y sangrado menstrual abundante.
- Síndrome premenstrual y TDPM.
- Endometriosis.
- Acné, hirsutismo (drospirenona o ciproterona).
- Regulación del ciclo menstrual.
- Prevención de anemia por hipermenorrea.

5. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Alta eficacia (>99% si uso correcto).	Dependencia del cumplimiento diario.
Reversibles y seguras.	Sangrado irregular al inicio.
Regulan ciclo y reducen dismenorrea.	Riesgo trombótico (estrógenos).
Disminuyen riesgo de cáncer de ovario y endometrio.	No protegen contra ITS.

Mejoran acné y seborrea.

Efectos adversos hormonales leves
(náuseas, cefalea).

6. Contraindicaciones

a.

Métodos combinados (según OMS – Categoría 4 = contraindicado)

Situación	Motivo
Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar activa o previa	Riesgo trombótico
Cáncer de mama actual o previo	Estimulación hormonal
Hepatopatía grave o tumores hepáticos	Metabolismo estrogénico alterado
Migraña con aura	Aumento riesgo de ACV
Hipertensión arterial no controlada	Riesgo cardiovascular
Fumadora ≥ 35 años (>15 cig/día)	Riesgo de trombosis y ACV
Lactancia <6 semanas postparto	Riesgo de trombosis y supresión láctea

b.

Métodos solo progestínicos

- Cáncer de mama actual.
- Sangrado genital no diagnosticado.
- Hepatopatía activa severa.

☐ En EUNACOM: “Mujer de 37 años fumadora pesada: contraindicado AOC, usar método solo progestínico o DIU.”

7. Efectos adversos frecuentes

Efecto	Comentario
Náuseas, cefalea, sensibilidad mamaria	Suele mejorar tras 2–3 ciclos
Sangrado intermenstrual	Común en primeros meses
Amenorrea	Frecuente con progestinas
Aumento leve de peso o retención hídrica	Estrógeno/progestina
Disminución de libido o cambios del ánimo	Individual

Tromboembolismo venoso (TEV): riesgo 2–3 veces mayor con AOC combinados, pero menor que durante el embarazo.

8. Elección del método según condición clínica

Condición	Método recomendado
-----------	--------------------

Adolescente sin patología	AOC combinados o implante
Lactancia <6 meses	Solo progestina (minipíldora, implante, inyectable)
Fumadora >35 años	Progestina sola o DIU-LNG
Dismenorrea / endometriosis	AOC combinados continuos o DIU-LNG
Obesidad	Progestina sola o DIU
Migraña con aura	Progestina sola
HTA controlada	Progestina sola o DIU
Postparto inmediato	Progestina sola

En Chile, los **métodos de larga duración reversibles (LARC)** —DIU-LNG e implante subdérmico— son promovidos por el **MINSAL** como primera elección por su alta eficacia y adherencia.

9. Manejo de olvidos (AOC combinados)

Retraso u olvido	Conducta
1 comprimido (<24 h)	Tomar inmediatamente y continuar esquema
2 o más comprimidos consecutivos	Tomar 1 comprimido al recordar + usar método de respaldo 7 días

Si olvido ocurre en última semana del blíster Iniciar nueva caja sin descanso

Vómito o diarrea intensa <3 h tras ingesta Repetir dosis y usar respaldo

□ Reglas de oro EUNACOM:

“Si olvidó una píldora: tomar al recordar.”

“Si olvidó ≥2: tomar y usar método de respaldo 7 días.”

10. Beneficios adicionales a largo plazo

- Reducción de cáncer de ovario (50%) y endometrio (70%).
 - Disminución de quistes ováricos funcionales.
 - Reducción de enfermedad pélvica inflamatoria.
 - Menor sangrado menstrual → prevención de anemia ferropénica.
 - Mejoría de acné y seborrea.
-

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas

1. **Mecanismo principal:** inhibición de la ovulación.
2. **Estrógeno + progestina:** método combinado; **solo progestina:** alternativa en lactancia y riesgo cardiovascular.
3. **Contraindicación absoluta:** fumadora >35 años, TEV, cáncer de mama, hepatopatía grave, migraña con aura.
4. **Efectos no anticonceptivos:** dismenorrea, acné, regulación menstrual.

5. **Implante y DIU-LNG:** mayor eficacia y adherencia (LARC).
6. **Progestina sola:** opción segura durante lactancia.
7. **No protegen contra ITS → siempre indicar preservativo adicional.**



Errores comunes

- Indicar AOC en fumadoras mayores de 35 años.
- Suspender AOC ante sangrado intermenstrual leve (suele ser transitorio).
- Olvidar agregar progestina en mujeres con útero bajo THR.
- No advertir sobre uso complementario en vómitos o diarrea.
- Prescribir sin evaluar historia familiar de trombosis o cáncer de mama.

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **métodos hormonales combinados** contienen **estrógeno + progestina** y actúan inhibiendo la ovulación.
2. Los **métodos solo progestínicos** se indican cuando el estrógeno está contraindicado (lactancia, riesgo vascular, fumadoras).
3. **Contraindicaciones absolutas:** trombosis, cáncer de mama, hepatopatía, migraña con aura, fumadora >35 años.
4. **Eficacia >99%** con uso correcto; los **LARC (implante, DIU-LNG)** son los más efectivos y con mayor adherencia.
5. **Efectos beneficiosos:** reducen dismenorrea, anemia, acné y riesgo de cáncer de ovario/endometrio.
6. En olvido ≥ 2 píldoras → tomar una al recordar + método de respaldo 7 días.
7. No protegen contra ITS → uso conjunto con **preservativo**.